

Unikanie *drugiej strony*

Druga strona body-checkingu: unikanie sytuacji z ciałem (lustra, obcisła odzież, plaża, intymność). Krótkoterminowo redukuje lęk, długoterminowo wzmacnia wstyd. Ekspozycja stopniowa.

CZAS: 30 min · hierarchia + plan Etap 3 CBT-E (sesje 12-16) · gdy napady zredukowane

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Rosen (1997); Cash (2008)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **typowe formy unikania ciała** (sekcja 1), zobacz, jak **ekspozycja stopniowa** działa analogicznie do leczenia lęków (sekcja 2). Sekcja 3 — Twoja hierarchia ekspozycji. Sekcja 4 — plan czterech tygodni.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Body avoidance to **druga strona** body-checkingu — unikanie sytuacji z ciałem: luster, obcisłej odzieży, plaży, basenu, intymności, zdjęć, krótkich rękawów. Opiera się na przekonaniu: „*jak tego unikam, nie czuję lęku*”. **Krótkoterminowo działa, długoterminowo wzmacnia** lęk, bo nigdy nie sprawdzasz swoich obaw *przeciwko rzeczywistości*. Fairburn (2008): *body avoidance* jest czasem bardziej ograniczające niż *body-checking* — klient rezygnuje z **części życia**. Rosen (1997) opracował *body image therapy* opartą na ekspozycji — analogicznie do leczenia zaburzeń lękowych. Cash (2008) rozwinął technikę hierarchii ekspozycji. Mechanizm: *habituacja* — wytrzymanie sytuacji uczy mózg, że można **tolerować** dyskomfort. Cel *nie* to „*pokochać swoje ciało*” — cel to *nie unikać* sytuacji, w których ciało jest obecne.

01 = Typowe formy unikania ciała

LUSTRA I ZDJĘCIA

Unikanie luster, brak zdjęć z sobą, niechęć do rodzinnych albumów.

UBRANIA LUŻNE, KRYJĄCE

Tylko luźne ubrania, bluzy nawet latem, długie rękawy, czerń. Brak obcisłych ubrań.

PLAŻA, BASEN, WODA

Brak wakacji nad morzem, basenów. Pozostawianie w ubraniach.

INTYMNOŚĆ

Unikanie seksu, intymność po ciemku, w pozycjach „*kryjących*”.

DOTYK CIAŁA

Pośpieszny prysznic, brak masażu, mycie w ciemności.

SYTUACJE SPOŁECZNE

Unikanie zajęć sportowych, przebieralni, masażu, ginekologa.

02 ● Mechanizm ekspozycji stopniowej

Bez ekspozycji: unikanie → chwilowa ulga → *muszę unikać* → coraz mniejszy świat.

Z ekspozycją stopniową: ekspozycja na niski lęk → **wytrzymanie** 15-30 min → lęk samoistnie opada → *można żyć z dyskomfortem* → **habituacja**.

Sześć elementów: (1) **identyfikacja** sytuacji unikania, (2) **hierarchia** od najłatwiejszych do najtrudniejszych, (3) **stopniowa** ekspozycja 4-8 tygodni, (4) **tolerancja** dyskomfortu, (5) **współczucie wobec siebie**, (6) **generalizacja**.

03 \ Moja hierarchia ekspozycji

Wypisz sytuacje, których unikasz, w **kolejności rosnącego lęku** (1–10). Najłatwiejsza na górze, najtrudniejsza na dole. Każdy poziom realizujesz, dopóki lęk znacząco nie opadnie (zwykle 3–5 ekspozycji), zanim przejdziesz do następnego.

LĘK 0–10	SYTUACJA UNIKANA	MAŁA WERSJA EKSPOZYCJI
2–3		
4		
5–6		
7		
8–9		

Przykładowa hierarchia: 2 — dotyk własnej skóry pod ubraniem; 4 — krótkie spojrzenie w lustro w bieliźnie; 6 — bardziej dopasowane ubrania w domu; 7 — krótki rękaw w pracy; 9 — strój kąpielowy na basenie.

04 Plan na cztery tygodnie

TYDZIEŃ 1 — POZIOM 2–3

Najłatwiejsza sytuacja z hierarchii. 3–5 ekspozycji w tygodniu, każda 15–30 min lub do opadnięcia lęku.

TYDZIEŃ 2 — POZIOM 4

Następny poziom, gdy lęk poprzedniego znacząco opadł (z 3 do 1). Konsekwencja: 3–5× w tygodniu.

TYDZIEŃ 3 — POZIOM 5–6

Stopień średni. Może wymagać wsparcia osoby zaufanej. Współczucie wobec siebie kluczowe.

TYDZIEŃ 4+ — UTRWALENIE

Konsolidacja zdobytego poziomu. Generalizacja na inne sytuacje. Kolejne poziomy hierarchii w kolejnych tygodniach.

Klucz: body avoidance jest *cichą wersją* upośledzenia funkcjonowania w bulimii — nie widać go w wynikach badań, ale realnie **ogranicza życie**. Niejedzenie obiadu z rodziną w wakacjach, rezygnacja z basenu z dzieckiem, unikanie intymności z partnerem — to wszystko *koszty*, których pacjent zwykle **nie liczy**, bo „*nauczył się żyć bez tego*”. Fairburn (2008): pacjenci po pełnym CBT-E z ekspozycją na ciało odzyskują dostęp do tych sytuacji — co przekłada się na **znacząco wyższą** jakość życia, niezależnie od fluktuacji wagi. Rosen (1997): *body image therapy* oparta na ekspozycji daje większy efekt długoterminowy niż sama praca poznawcza — bo pacjent doświadcza **na własnej skórze**, że można żyć z dyskomfortem o ciało i że dyskomfort opada. Cash (2008): kluczowe jest *współczucie wobec siebie* — ekspozycja jest trudna, każda udana próba zasługuje na uznanie, nieudana nie jest porażką. Cel *nie* to „*pokochar swoje ciało*” — cel to **nie unikać** sytuacji, w których ciało jest obecne. To realistyczny, osiągalny cel — i jego osiągnięcie zwraca dużą część życia.